

Eva Gracia | Mamá (contra) Corriente

Cómo lograr un embarazo

conociendo tu fertilidad

Método sintotérmico
Test de ovulación y embarazo

Copyright © 2017 Eva Gracia | Mamá (contra) corriente. Todos los derechos reservados.

Te agradezco muchísimo tu confianza comprando este ebook que he escrito con todo mi cariño y rigor para que te sea útil. Por favor, no redistribuyas este libro ni parte de él a terceros. Si necesitas hacer una copia personal, escríbeme a hola@mamacontracorriente.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción 4
Lo que debes saber en el plano teórico 6
El ciclo femenino 7
Fertilidad masculina 10
Método sintotérmico: qué es y cómo funciona 12
a. ¿Qué necesitamos? 14
b. Temperatura basal 16
c. Observación del moco cervical 18
d. Control de la posición y apertura del cuello uterino 20
e. Consideraciones si buscas un embarazo 22
f. Consideraciones si deseas evitar un embarazo 24
Lo que he aprendido de fertilidad y sintotérmico (mientras buscaba el embarazo de mis hijos) 26
Guía de uso de los test de ovulación 28
¿Adelantan los test de ovulación el positivo por embarazo? 32
¿Es normal obtener siempre dos rayitas en los test de ovulación? 38
La línea de evaporación en los test de embarazo 42
¿Cuándo podría dar positivo un test de embarazo de alta sensibilidad? 48
Patrón espermático (o cada cuánto hacerlo para concebir) 57
¿Se puede elegir el sexo del bebé? 60
Embarazo: cuentas oficiales y cuentas propias 64
¿Síntomas de embarazo?: Todos… ¡o ninguno! 69
Test de embarazo en sangre: niveles de Beta hCG 72
Recursos útiles 78

Introducción

Tradicionalmente **las mujeres hemos sido portadoras de una gran sabiduría**, transmitida de madres a hijas, **que nos permitía conocer nuestros cuerpos**: nuestro ciclo menstrual, el momento de la gestación y el parto o el *arte* del amamantamiento, por ejemplo.

Estos conocimientos se han ido perdiendo poco a poco por la lejanía de las familias en las grandes ciudades, la falta de *tribu*, la aparición de métodos más sofisticados supuestamente mejores...

De este modo, **se ha ido abandonando lo tradicional como si fuera algo malo**, en lugar de seguir apoyándonos en la sabiduría adquirida durante siglos para complementar los nuevos medios de planificación familiar.

Empecé a utilizar el método sintotérmico en 2008, tras casi un año de búsqueda infructuosa de un bebé que se resistía a llegar.

Por aquel entonces yo no sabía nada de mi ciclo menstrual y lo veía como una pesada carga que nada me aportaba. Desconocía que existían días del ciclo en los que era más fácil quedar embarazada y días en los que era imposible, creía que las reglas podían adelantarse o atrasarse como por obra de magia, nunca me había planteado por qué mi flujo vaginal variaba a lo largo del mes…

En síntesis: desconocía por completo cómo funcionaba la fertilidad humana y, por ende, mi ciclo menstrual me resultaba un enigma.

Cuando a finales de 2009 empecé a escribir mi blog Mamá (contra) corriente, tuve claro que quería compartir con mis lectores los conocimientos que había adquirido sobre fertilidad, ciclo femenino y planificación familiar natural.

Tras haber tenido a mis dos hijos gracias al *enorme empujón* que te da conocer y aplicar el método sintotérmico, combinándolo con el uso de test de ovulación, son decenas las consultas que recibo todas los semanas preguntándome por todas aquellas dudas que yo también tenía cuando empecé.

Por eso he decidido escribir este ebook. En el reúno mis conocimientos teóricos en fertilidad y método sintotérmico con los que todo lo que yo he aprendido durante estos años en el plano más práctico.

Como yo, **tú también puedes llegar a comprender**, de una forma sencilla y muy práctica, **cómo funciona la fertilidad femenina y tu ciclo menstrual**.

Te sorprenderá lo fácil que resulta y la satisfacción que produce conocer y escuchar tu propio cuerpo.

Además, **identificar tus días fértiles**, aprender a reconocer cuándo es el momento adecuado, **te ayudará a maximizar tus posibilidades de quedar embarazada**.

¡Vamos allá!

Eva Gracia
Mamá (contra) corriente

Lo que debes saber en el plano teórico



El ciclo femenino

El ciclo sexual femenino es el proceso mediante el cual se libera un óvulo y se producen una serie de cambios físicos y hormonales en el cuerpo de la mujer dirigidos a obtener un embarazo.

El inicio del ciclo es siempre el primer día de la menstruación.

Se considera que **el último día del ciclo es el día anterior al de la siguiente regla.**

Se considera que **los ciclos duran 28 días**. Esto **es una convención pura y dura**. Muchas mujeres tienen ciclos más cortos, más largos o de duración variable.

El ciclo menstrual tiene tres fases:

1.Menstruación

No ha habido embarazo.

El endometrio, que estaba preparado para albergar el óvulo ya fecundado, se desprende.

Llega así la menstruación.

2. Fase folicular o proliferativa

El ovario produce estrógenos, el óvulo madura y el endometrio se va engrosando de nuevo.

En los ovarios tenemos varios folículos pero sólo uno será el que madurará en cada ciclo y finalmente será liberado (salvo que excepcionalmente ovulemos dos veces).

Los estrógenos, que favorecen que el útero se predisponga a albergar un óvulo fecundado, hacen que las criptas del cuello uterino produzcan moco cervical abundante y de características fértiles, para ayudar a los espermatozoides a cumplir su función.

En un momento dado se producirá una oleada de hormona luteinizante (LH), que determinará que el óvulo que ha madurado finalmente se libere y se deslice por las trompas de Falopio, a la espera de ser fecundado.

Esta es la hormona que analizan los test de ovulación. Detectar su aparición predecirá que la ovulación está a punto de ocurrir.

El óvulo vive durante muy poco tiempo, se considera que una media de 24 horas, quizá menos.

La fase folicular puede tener una duración variable. En muchas mujeres se mantendrá más o menos constante y se considera que la ovulación tendrá lugar el día 13 o 14 del ciclo, pero en muchas otras tendrá una duración mayor o menor cada vez. En mi caso, habitualmente ovulo entre los días 17 y 19 del ciclo.

3. Fase lútea

El cuerpo lúteo, formado en el ovario tras haber liberado al óvulo, continúa creciendo y fabricando hormonas, especialmente la progesterona.

La protegesterona es una hormona básica en el embarazo. Ella producirá que la temperatura basal se eleve y favorecerá que el endometrio se engrose para que el blastocito pueda implantarse en él.

Si no hay embarazo, la progesterona caerá y llegará la menstruación.

Si hay embarazo, el embrión produce gonadotropina coriónica humana (hCG), una hormona muy similar a la hormona luteinizante (LH). La hormona hCG es la que analizan los test de embarazo.

La fase lútea se mantiene estable en todas las mujeres.

La fase pre-ovulatoria puede variar de un ciclo a otro en una misma mujer, pero la fase lútea permanece estable.

Cada mujer tiene una duración personal de la fase lútea, considerándose normal entre 10 y 16 días.

Una duración inferior podría indicar que existe algún problema de insuficiencia lútea que imposibilitaría el mantenimiento de un blastocito en el endometrio y una duración superior sería indicio de embarazo.

Fertilidad masculina

En el semen que expulsa el hombre durante la eyaculación viajan millones de espermatozoides, con capacidad para vivir hasta cinco días en las trompas de Falopio y el útero de la mujer tras el coito.

Para desplazarse, alcanzar el óvulo y fecundarlo, los espermatozoides utilizan su flagelo y se sirven tanto de la viscosidad del semen como del moco cervical presente en la vagina y cuello uterino de la mujer, que si está en periodo fértil, será especialmente útil tanto para su deslizamiento como para su supervivencia.

Los espermatozoides mantienen su capacidad para fertilizar un óvulo incluso después de ser congelados o criopreservados.

Son los espermatozoides los que determinan el sexo del embrión, puesto que pueden llevar el cromosoma X o el Y, mientras que el óvulo sólo lleva el cromosoma X.

Dos cromosomas X en el par 23 darán lugar a una niña, mientras que la combinación XY dará lugar a un varón.

El esperma del hombre puede ser de mejor o peor calidad pero mientras exista al menos un espermatozoide con capacidad de fecundar siempre existirá capacidad para conseguir un embarazo.

Algunos problemas en relación con los espermatozoides podrían ser:

- **Oligospermia**. Bajo recuento de espermatozoides.

- **Teratozoospermia**. Alteraciones morfológicas en los espermatozoides respecto con la forma estandarizada: no tener flagelo, tener dos cabezas, etc. Que tengan una morfología anormal no quiere decir, per se, que no tengan capacidad para fecundar, aunque sí podrían tener serios problemas para alcanzar el óvulo sin ayuda.

- **Astenozoospermia**. Baja movilidad de los espermatozoides.

- Combinaciones de las anteriores, por ejemplo, espermatozoides lentos y con muchas formas alteradas, que se denominaría astenoteratozoospermia.

Obtener una de estas “calificaciones” en un seminograma puede ser un jarro de agua fría para cualquier pareja pero lo cierto es que no son una sentencia definitiva de infertilidad.

Cada seminograma puede dar resultados distintos, además de que su observación es subjetiva.

Método sintotérmico: qué es y cómo funciona

El método sintotérmico es un método de observación del cuerpo femenino que permite conocer el ciclo menstrual de cada mujer y, por tanto, puede emplearse como un método natural de planificación familiar, como así lo avala la OMS.

Se basa en tres observaciones, complementarias entre sí:

- Temperatura basal.
- Consistencia y sensación del flujo vaginal.
- Apertura y elevación del cuello cervical.

El mayor nivel de conocimiento lo adquiriremos utilizando las tres comprobaciones pero pueden usarse de manera independiente.

De hecho, gran parte de las usuarias se limitan a comprobar su temperatura basal y quizá su moco cervical, no atendiendo a la posición del cuello cervical.

Es más, una vez adquirida cierta experiencia con nuestro propio cuerpo, bastará la observación de una sola de estas variables para que podamos conocer en qué momento del ciclo nos encontramos casi sin pensarlo, de forma automática y natural.

Ser conscientes de nuestro ciclo menstrual nos puede a ayudar a:

- Detectar si tenemos algún problema en nuestro ciclo que antes desconociéramos, por ejemplo, si no ovulamos, o si tenemos una fase lútea demasiado corta. Se acabaron las dudas si no nos viene la regla, si tenemos un manchado corto que no sabemos a qué responde...
- Evitar un embarazo sin utilizar ningún otro método anticonceptivo. O combinar este método con uno de barrera durante los días fértiles, para excluir cualquier posibilidad de embarazo sin renunciar a mantener relaciones sexuales cuando nos apetezca.
- Buscar un embarazo, resultando especialmente útil en mujeres con ciclos irregulares y/o especialmente cortos o largos.

En España el método sintotérmico es poco conocido.

Algunas personas que sí han oído hablar de él tienen ciertos reparos por considerarlo poco seguro. O incluso prejuicios, ya que es el único método que admite la Iglesia Católica como regulador de la natalidad, pues para evitar tener descendencia se debe practicar abstinencia durante el periodo fértil de la mujer.

Lo cierto es:

- Que el método sintotérmico es pura ciencia.
- Aplicado con rigor es muy seguro como método anticonceptivo, tanto como la píldora, por ejemplo.
- Como medio para buscar un embarazo su tasa de éxito es elevadísima. ¡Somos muchas las parejas que sin este método quizá todavía no tendríamos hijos!

a.¿Qué necesitamos?

Para llevar a cabo la observación de nuestro ciclo, simplemente necesitamos:

- Un papel
- Un boli
- Un termómetro, preferiblemente basal.

El termómetro basal es un termómetro que cubre un rango más pequeño de grados centígrados pero que, a cambio, tiene mayor amplitud entre los decimales, de forma que se puede detectar cualquier mínimo cambio. Esto es importante porque para el método sintotérmico cualquier diferencia de una décima es decisiva.

Debido a la necesidad de precisión, es necesario que hagamos una buena elección de nuestro termómetro basal. En la actualidad en Amazon se pueden encontrar modelos que ofrecen mediciones muy precisas y que no resultan caros.

Los termómetros de mercurio se han retirado de las farmacias hace ya varios años por ser muy tóxica esta sustancia.

Para los que no quieran un termómetro digital, los de mercurio se han sustituido por termómetros de galio. Son igual de precisos pero mucho más fáciles de romper. En muchas farmacias no los tienen pero se pueden comprar online sin dificultad.

En cuanto al papel y el boli, se trata de hacer una gráfica donde podamos anotar tanto la temperatura basal diaria como nuestras observaciones sobre el cuello uterino y el moco cervical, así como cualquier otro signo que consideremos relevante (dolor de cabeza, aparición de granitos, calambres en los ovarios, somnolencia, gases, etc).

A mi el formato de papel me gusta mucho porque permite una gran personalización pero si no os gusta, hay opciones digitales que resultan muy prácticas. Tanto páginas web como 28días.es como apps que podemos descargar en nuestro smartphone, muchas de ellas gratuitas al menos en sus versiones básicas.

b.Temperatura basal

La temperatura basal es aquella que tenemos cuando nuestro cuerpo está en reposo.

Esta temperatura se mantiene baja al inicio del ciclo y sube una vez que hemos ovulado, por acción de la progesterona, la hormona liberada durante el proceso.

La temperatura se mantendrá elevada desde el momento de la ovulación y hasta horas antes de que aparezca nuestra menstruación, salvo que quedemos embarazadas, en cuyo caso se mantendría alta.

Para controlar nuestra temperatura basal basta con ir registrando en una gráfica nuestra temperatura nada más despertarnos por la mañana, tomada en la vagina, el ano o debajo de la lengua (este último sitio suele ser el más escogido y el que yo recomiendo).

Todos los días a la misma hora, nada más despertarnos, sin movernos más que para coger el termómetro, que debe estar listo en la mesilla. Deberemos haber dormido un mínimo de 5 horas antes de tomarnos la temperatura.

Hay que registrar si algún factor externo ha podido alterar la temperatura que hemos anotado y no tenerla en cuenta si es preciso. Por ejemplo, trasnochar, estar enferma, cambiar de termómetro, beber alcohol, tomar algún tipo de medicación... todo esto puede alterar nuestra temperatura basal y debe considerarse para ser precisos.

En muchos casos, el día en que se produce la ovulación se observa una leve bajada de la temperatura, para registrarse un pico al día siguiente, manteniéndose alta la temperatura en los días siguientes, lo cual nos indica que la ovulación se ha producido.

En ese momento sabremos que hemos ovulado y que se ha iniciado la fase lútea; los días de antes y los de después serán los más fértiles, puesto que los espermatozoides pueden llegar a vivir hasta cinco días dentro del útero.

Debe quedar claro que el día de la ovulación no es el primer día de temperatura elevada sino justo el anterior.

A partir de la tercera noche de subida de temperatura, se descarta que el embarazo pueda producirse.

Para estar seguras de que la ovulación se ha producido, debemos atender a unas reglas muy sencillas:

- **Deben darse tres valores de temperaturas altas de forma consecutiva**, mayores a los valores de los seis días previos.

- **El tercer día la temperatura debe ser al menos dos décimas por encima del valor más alto de los seis anteriores.**

- **Si la temperatura del tercer día no estuviera dos décimas por encima, hay que esperar al cuarto día.** La temperatura aquí debería ser mayor que las seis anteriores pero ya no se exige que sea al menos dos décimas mayor.

c.Observación del moco cervical

Durante el ciclo podremos observar que nuestro flujo vaginal no es siempre igual.

¿Alguna vez os habéis preguntado por qué durante algunos días al mes tenemos más cantidad, a veces incluso muy abundante, y de una consistencia un tanto especial? La respuesta es fácil: nuestro cuerpo produce un moco cervical especialmente fértil, destinado a facilitar la llegada de los espermatozoides a su destino.

Debemos observar, al menos una vez al día, las características de nuestro moco cervical, tomando un poco con los dedos, lo que encontremos justo en la parte externa de la vagina, sin necesidad de introducirlos.

En la gráfica de temperatura basal **iremos anotando las sensaciones** que observamos: cantidad (seca, poco, mucho), características (pegajoso, líquido, elástico, clara de huevo) y color (blanco, transparente, amarillo).

Tras la menstruación normalmente tendremos una sensación de sequedad.

La sensación de humedad irá aumentando hasta que, por acción de los estrógenos, empecemos a observar moco cervical de características fértiles: color transparente, consistencia elástica, mayor cantidad.

El moco cervical más fértil es aquel que coloquialmente llamamos clara de huevo. Su consistencia es tan elástica que si separamos los dedos podremos formar hebras. Es un moco muy característico y fácilmente reconocible.

Los días del periodo menstrual que sean teóricamente secos, no se consideran días seguros porque no podremos observar el moco y, recordemos, los espermatozoides pueden llegar a vivir hasta cinco días dentro del cuerpo de la mujer. Esto debe tenerse en cuenta especialmente en las mujeres con ciclos cortos.

La observación del moco cervical, por sí sola, constituye un método de control de observación de fertilidad, llamado **método Billings**.

d.Control de la posición y apertura del cuello uterino

Muchas mujeres prescinden de este control pero la OMS considera que el método sintotérmico implica la comprobación de los tres parámetros.

Yo lo he empleado en algunos ciclos y me parece realmente fascinante y muy fiable pero también creo que combinando temperatura basal y moco cervical tendremos un muy buen conocimiento de nuestro ciclo. Queda al criterio de cada mujer emplearlo o no, siempre teniendo claro que lo más riguroso y es hacer las tres comprobaciones.

El cuello del útero se modifica a lo largo del ciclo: tras la menstruación se encuentra cerrado, duro, y bajo dentro de la vagina.

Conforme se acerca la ovulación se vuelve más blando y más abierto, ascendiendo dentro de la vagina.

Tras la ovulación vuelve a la posición cerrada, dura y baja.

Para observarlo, recomiendo ponernos ligeramente flexionadas, como si quisiéramos ponernos en cuclillas, e introducir un dedo en la vagina (limpio y con las uñas cortas, lógicamente) hasta que logremos palpar una pared: el cérvix. Si enseguida encontramos ese "*tope*", tendremos claro que su posición es baja y, por tanto, no estamos en un momento fértil.

Si nos cuesta mucho tocar el cuello del útero, incluso a veces es casi imposible, entonces podemos estar seguras de que la ovulación está muy cercana.

Puede resultar algo incómodo realizar esta comprobación, sobre todo al principio, pero por mi experiencia puedo asegurar que resulta asombroso y fascinante comprobar cómo se modifica nuestro cérvix a lo largo del ciclo sin que seamos conscientes de ello. Os recomiendo que lo probéis, al menos una vez.

e.Consideraciones si buscas un embarazo

Emplear el método sintotérmico es una opción estupenda para todas aquellas personas que están buscando tener un bebé, puesto que permite conocer los días más propicios para conseguir un embarazo.

Es especialmente útil en aquellas mujeres con ciclos irregulares, parejas con problemas de fertilidad, etc. Sabiendo cuáles son nuestros días fértiles, nos será más fácil *atinar*.

Dado que los espermatozoides pueden llegar a vivir hasta cinco días dentro del útero, para conseguir un embarazo se recomienda tener relaciones con frecuencia, intensificándolas algunos días antes del periodo fértil (por ejemplo, comenzar seis días antes de la ovulación) y continuar hasta el tercer día post-ovulatorio.

Una vez que conozcamos nuestro ciclo, podremos detectar con facilidad los signos que nos indican que vamos a ovular, pudiendo, si queremos, planificar las relaciones sexuales para conseguir un embarazo.

En muchas gráficas con resultado de embarazo se observa un **patrón trifásico**, es decir, un primer periodo de temperaturas bajas, un periodo de temperaturas altas y otro periodo de temperaturas aún más altas.

Esto ocurre porque, en algunas ocasiones, se produce una pequeña bajada de temperatura al anidar el blastocito y a continuación sus valores suben algo más, produciéndose este patrón tan claro de tres fases. Pero no siempre será así, por lo que puede haber embarazo perfectamente sin darse esta circunstancia. No debemos obsesionarnos buscando este patrón trifásico en nuestras gráficas.

Si tu objetivo es lograr un embarazo, el uso de test de ovulación puede complementar estupendamente el uso del método sintotérmico. Hablaré de su uso e interpretación en la parte práctica del libro.

f. Consideraciones si deseas evitar un embarazo

Emplear el método sintotérmico como método para evitar un embarazo requiere de un alto nivel de compromiso y constancia.

Hay que tener en cuenta que los errores en la observación de los signos de fertilidad o en su interpretación pueden llevar a un embarazo no deseado.

No obstante, siempre es posible combinar el método sintotérmico con métodos de barrera si tenemos dudas de si estamos en periodo fértil o no. A cada pareja corresponde actuar con responsabilidad y decidir si puede tener relaciones o no en base a la observación del ciclo que están realizando.

Para utilizar el método sintotérmico como método de prevención de un embarazo, es necesario que determines con exactitud cuáles son tus periodos infértiles pre-ovulatorios y post-ovulatorios:

- Infertilidad pre-ovulatoria

  Regla “menos 20”

  Al número de días del ciclo más corto hay que restarle 20. El resultado será el último día infértil en la fase pre-ovulatoria, siempre que no aparezca moco y/o humedad antes.

  Regla “menos 8”

  Primer día de subida de la temperatura menos 8. El resultado será el último día infértil en la fase pre-ovulatoria siempre que no aparezca moco y/o humedad antes.

Ambos días se obtienen a partir del primer día de los últimos 12 ciclos.

Los primeros cinco días del ciclo no son fértiles siempre y cuando en esos días no aparezca moco y no haya cambios en el cuello uterino que indiquen lo contrario.

Los días encontrados mediante el cálculo menos 20 o mediante el cálculo menos 8 son infértiles siempre que no aparezca moco y/o humedad antes.

- El periodo infértil post-ovulatorio comienza en la noche del tercer día después del pico del moco o en la noche del tercer día tras el aumento de temperatura (lo que ocurra después) y hasta la menstruación.

Si deseas emplear el método sintotérmico como medio para evitar embarazos, te recomiendo que acudas a un grupo de orientación donde te puedan formar convenientemente acerca de las reglas a tener en cuenta y hacer un seguimiento de las gráficas durante varios meses, hasta que tengas el dominio suficiente y puedas hacerlo con seguridad.

Por supuesto, puedes hacerlo por tu cuenta, pero creo que es interesante que alguien te acompañe en este aprendizaje.

Lo que he aprendido de fertilidad y sintotérmico
(mientras buscaba el embarazo de mis hijos)



Durante los últimos 7 años he tratado en muchos artículos de mi blog temas de fertilidad, método sintotérmico y uso de test de embarazo y ovulación.

Son decenas las consultas que respondo todas las semanas.

La búsqueda del embarazo, la incertidumbre cuando no llega, es una circunstancia muy dura para muchas familias, que no siempre reciben la orientación ni el apoyo necesario.

Por desgracia, nosotros lo sabemos por experiencia.

Y ha sido esa experiencia la que me ha llevado a tener tanto interés por la ciencia que hay detrás del ciclo femenino y, también, por experimentar en el plano más práctico todas aquellas preguntas que suelen surgir y que llenan los foros de fertilidad con cientos y cientos de consultas.

A continuación recopilo buena parte de la información que he compartido en estos años, con todo lo que he aprendido en el plano práctico mientras buscaba el embarazo de mis dos hijos.

Guía de uso de los test de ovulación

Los ciclos menstruales de la mujer están regidos por varias hormonas que intervienen en momentos distintos del proceso.

En concreto, la ovulación está regida por la hormona luteinizante (LH), que es la que estimula la maduración del folículo (el óvulo) y la ovulación.

Los test de ovulación miden la concentración de la hormona LH para averiguar cuáles son los días más fértiles.

El empleo del método sintotérmico, que defiendo como excelente para conocer el ciclo femenino, nos dará a conocer que la ovulación se ha producido una vez que hayamos detectado una subida de temperatura de forma sostenida.

Dicho de otro modo, con el método sintotérmico podremos comprobar que hemos ovulado, pero *a posteriori*. Desgraciadamente, el óvulo de una mujer apenas puede vivir unas 12-24 horas, por lo que cuando detectemos la ovulación por medio de la subida de temperatura el óvulo probablemente haya muerto y sea tarde para tener relaciones sexuales con idea de fecundarlo. Por ello, necesitamos conocer cuándo vamos a ovular de manera previa a que se produzca el hecho.

Para conocer nuestros días fértiles podemos emplear varios métodos, siendo, desde mi punto de vista, la observación del moco cervical y el análisis de las gráficas de temperatura basal uno de los más fiables. Pero, probablemente, estas observaciones requieran cierto empeño por parte de la mujer, necesitan cierta dedicación y los test de ovulación puedan ayudarnos con algo menos esfuerzo.

La teoría de los test de ovulación es sencilla: una vez que hayamos obtenido el positivo, la ovulación se producirá en las siguientes 24-48 horas. Una vez producida la ovulación, la hormona LH deja de producirse y es sustituida por la progesterona, entre otras, provocando la subida de temperatura basal de la que he hablado antes.

El positivo de un test de ovulación no es como el de un test de embarazo. Es necesario que las dos líneas sean de la misma intensidad. Esto es debido a que la hormona LH siempre está presente en nuestro organismo aunque sea en pequeñas cantidades. Si la línea de test es de menor intensidad, no se considera positivo sino negativo. Eso sí, hay que considerar que si con el paso de los días la línea va siendo más oscura e intensa, es que la ovulación se acerca.

La mayoría de los fabricantes de test de ovulación incluyen un cuadro en el que explican a partir de qué día es conveniente empezar a realizarse estos test en la orina, en función de la duración habitual de nuestros ciclos menstruales.

En mi caso, que tengo ciclos de unos 31 días, testar antes del día 14 del ciclo es tirar el dinero, yo suelo ovular sobre el día 17, más o menos.

Ante la duda, yo recomiendo pasarse por exceso, no por defecto. ¿Por qué?. Si testamos pocos días corremos el riesgo de no ver nunca un positivo, algo que es muy frecuente. Es más, **el pico de la hormona LH puede ser tan breve que mi recomendación es la de hacer tres test diarios durante los días que sospechamos que son fértiles**. Sólo de esa manera yo he conseguido ver un positivo en algunos ciclos.

La primera orina de la mañana en teoría no debe utilizarse porque es demasiado concentrada y podría dar lugar a falsos positivos… en la práctica, a mi esa orina siempre me da negativo-blanco nuclear. Lo ideal es hacerse el test todos los días a la misma hora y cuando entremos en la fase de hacer tres diarios, también siempre a la misma hora, por ejemplo, a las 9h, a las 15h y a las 21h. Yo lo que he hecho en muchas ocasiones es ir pegando las tiras de los test en un folio, etiquetándolas con un rotulador con fecha y hora, para poder ver la progresión.

¿Y si nunca veo un positivo? A mi me ha ocurrido en varios ciclos. Normalmente es porque no he hecho suficientes test y, en mi caso, debo tener una LH bajita y un pico muy breve. Si hemos tenido la paciencia de conservar todos los test que nos hemos hecho, al menos deberíamos ser capaces de observar que un día o dos la línea de test ha sido más intensa que los demás días.

¿Los recomiendo? Desde mi punto de vista, los test de ovulación son una ayuda prescindible. Creo que es mucho más útil y fiable el conocimiento del propio cuerpo por medio de la temperatura basal, el moco cervical y la posición del cérvix. La ayuda que nos proporcionan los test de ovulación está bien pero dado que está sujeta a múltiples factores, puede llevarnos a cometer errores de interpretación, por ejemplo, a pensar que no hemos ovulado cuando sí que lo hemos hecho.

En cualquier caso, nos debe quedar clara una cuestión: sólo una ecografía puede determinar a ciencia cierta en qué momento se produce la ovulación. Lo único que podemos hacer nosotros es aproximarnos el máximo posible al cálculo de ese momento para aumentar las posibilidades de concepción.

¿Adelantan los test de ovulación el positivo por embarazo?

Una de las consultas estrellas sobre embarazo es si los test de ovulación dan positivo de embarazo y no ovulación días antes de la menstruación, cuando un test de embarazo normal aún no daría positivo.

¿Enrevesado? Con lo que ya he explicado estos días creo que queda claro que la desesperación lleva a creer en muchas cosas, unas más verosímiles que otras, y esta teoría está ya muy extendida, hasta el punto de que casi todos la damos por cierta.

Desde el punto de vista de un escéptico, un test de ovulación sólo puede dar positivo cuando mide la suficiente cantidad de la hormona luteinizante (LH) en la orina de la mujer, hormona que tiene todo que ver con la ovulación pero en teoría tiene poca relación con el embarazo. La hormona que miden los test de embarazo es la Gonadotrofina Coriónica Humana (conocida como hCG). ¿Guardan relación ambas hormonas? ¡Qué lío!

No he sido nunca capaz de encontrar una explicación coherente en Internet que me convenciera lo suficiente así que decidí contactar con Anna, médico, mamá y blogger en Una historia Clínica.

Esta es su explicación:

- *Los TO mide la LH, que tiene muuuchas funciones en el ciclo reproductivo. Pero cuando nosotros vemos una alta concentración de LH, que es lo que determina el TO, nos indica sólo que ha habido ovulación.*

- *Los TE mide la beta-HCG, que aumenta cuando hay embarazo (y alguna enfermedad, pero eso olvídalo!). Por lo tanto, cuando aumenta en un test, podemos decir que hay embarazo… aunque luego hay que comprobarlo con la eco.*

- *Lo que pasa es que si nosotros hacemos un TE y sale negativo (porque la beta-HCG no ha aumentado todavía lo suficiente), pero nuestro TO es positivo y no ha habido regla significa que ha habido ovulación (es lo que dice el TO), pero si no ha habido pérdidas será porque el óvulo ha sido fecundado y todavía no ha aumentado lo demás para dar positivo el TE.*

- *Es por eso que, a veces, coincide un TO positivo con un TE negativo y se asume, o coincide, con que hay embarazo… a pesar de que la función del TO no es esa, sino sólo determinar si esa mujer ovula o no.*

- *¿Qué puede pasar (para desmontar la leyenda)? Que el TO diera positivo (ha habido ovulación), el TE negativo y, creyendo que el TE está tardando en dar positivo se asuma que hay embarazo, cuando en realidad lo que pasa es que la regla se ha retrasado…*

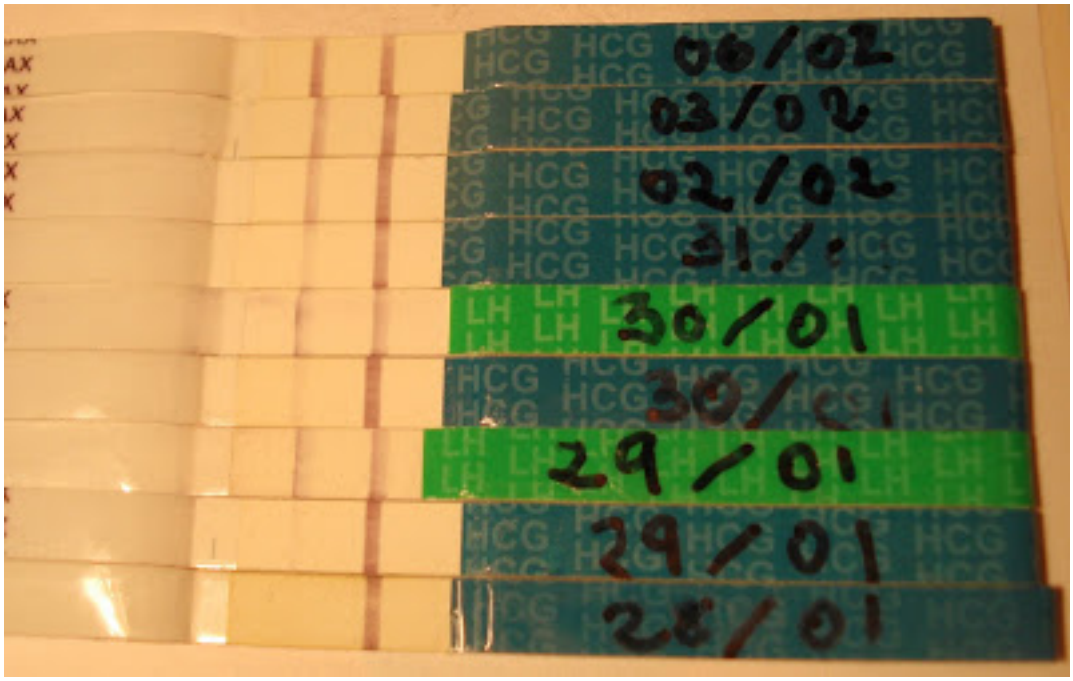
- *Cada ciclo pueden pasar mil cosas. A veces la ovulación se adelanta pero el endometrio no está preparado para "descamarse" y por eso no hay regla, por ejemplo.*

- *Por eso, lo más sensible para determinar embarazo es el TE (la beta-HCG en orina), porque si aumenta casi casi seguro que hay embarazo… y por eso no hay que fiarse mucho del TO para esto, aunque muchas veces coincide.*

Hasta aquí, la teoría. Ahora viene la parte práctica, la parte en la que yo comento mi experiencia y llego a la fantástica conclusión de… sí predicen el embarazo pero con ciertas reservas.

Cuando me quedé embarazada de mi hijo, yo estaba en un ciclo en el que todo me importaba ya un pimiento. Estaba agotada de intentarlo sin éxito y sólo quería que me viniera la regla para tomarme el Omifin que me acababa de recetar el ginecólogo. Fue el destino el que quiso que me diera un ataque de locura y rescatara de la basura el test de embarazo que minutos antes me había dado negativo para descubrir que, ¡oh, sorpresa!, ahí había una sombra que parecía un positivo (28 de enero en la foto, el primer test de abajo).

Al día siguiente decidí hacerme test de ovulación y test de embarazo y ambos dieron positivos. En la foto podéis ver a lo que me refiero (29 de enero). Los test está ya algo desgastados y amarillos, la líneas se han descolorido un poco, pero todavía puede apreciarse bien. Los test de ovulación son los verdes, los de embarazo los azules.



Al día siguiente repetí ambas pruebas (30 de enero). El test de ovulación sacó una línea de test aún más oscura que la de control, es decir, un súper positivo (que en la foto no se aprecia). Y el test de embarazo dió un positivo más marcado. No cabía duda, estaba embarazada y, además, la leyenda urbana era cierta.

Aquello me hizo creer a pies juntillas que la profecía era cierta y he mantenido ese pensamiento durante bastante tiempo. Sin embargo, mi adicción a los test y el interés en comprobar hasta qué punto se cumple siempre esta regla me ha hecho comprobar en varias ocasiones que no es todo tan bonito como parece.

Cuando me he hecho test de ovulación días antes de la regla, en ciclos que no han acabado en embarazo, no he obtenido positivos pero tampoco negativos rotundos. Siempre he visto dos líneas y en algunas ocasiones he llegado a ver dos líneas de una intensidad bastante similar. Cualquier persona con exceso de entusiasmo podría haber llegado a forjarse falsas esperanzas, considerando además que soy una persona que bebe bastante agua y hago pis con bastante frecuencia, es decir, que mi orina debe ser poco concentrada (y probablemente con más concentración daría una línea de test más marcada).

En definitiva, para poder hacerse ilusiones deben darse dos situaciones:

- Que el test de ovulación sea positivo, pero positivo de verdad, con dos líneas igual de intensas o, idealmente, con la línea de test más marcada que la de control.

- Que pueda observarse una progresión en la intensidad de esa línea durante al menos dos o tres días, igual que ocurre con la línea del test de embarazo, que cada vez se marca más.

La segunda situación es importante. En este último ciclo he hecho la prueba para poder comentarlo aquí y, sí, he obtenido dos líneas bastante marcadas (nunca con intensidad suficiente para darlo por positivo, pero bien visibles) y, sin embargo, todos los días eran iguales, no existía progresión ascendente en absoluto.

Quizá por esto en los foros existen testimonios para todos los gustos. Gente que dice haber tenido test de ovulación positivos con embarazo y gente que dice haber obtenido positivos y, después, la regla. En cualquier caso, como no podemos conocer el caso personal de cada mujer ni su ciclo ni cómo ha realizado e interpretado los test, siempre nos cabe la duda. Y, con ella, la leyenda sigue creciendo.

¿Es normal obtener siempre dos rayitas en los test de ovulación?

Durante años he estado probando intensivamente los test de ovulación y de embarazo porque quería comprobar en mi propio ciclo varias dudas compartidas en el blog en numerosas ocasiones.

¿Test de ovulación que siempre marcan dos rayitas?

Una de las preguntas que me han hecho varias personas es si **es normal que durante el uso de los test de ovulación en un ciclo normal (casi) siempre se obtengan dos rayitas, la de control y la de test, aunque la de test sea muy suavecita**. Y es una de las cosas que yo misma he querido comprobar en mi cuerpo para poder dar una respuesta, pues cuando los usé en 2009 me limité a los días que yo consideraba fértiles y nada más. Por eso no traté este tema cuando escribí sobre cómo usar los test de ovulación.

Mis pruebas

En esta ocasión, casi todos los meses **he estado realizándome tests de ovulación cada día del ciclo, excluyendo los de la menstruación**.

El resultado obtenido es el siguiente:

1.- **A comienzos del ciclo el test habitualmente no muestra dos rayitas sino únicamente la de control.**

2.- **A los pocos días (antes del día 10 del ciclo) comienza a aparecer esa segunda línea**, rosita suave, es decir, indicando negativo pero presencia de la hormona, y se mantiene así hasta el momento de la ovulación.

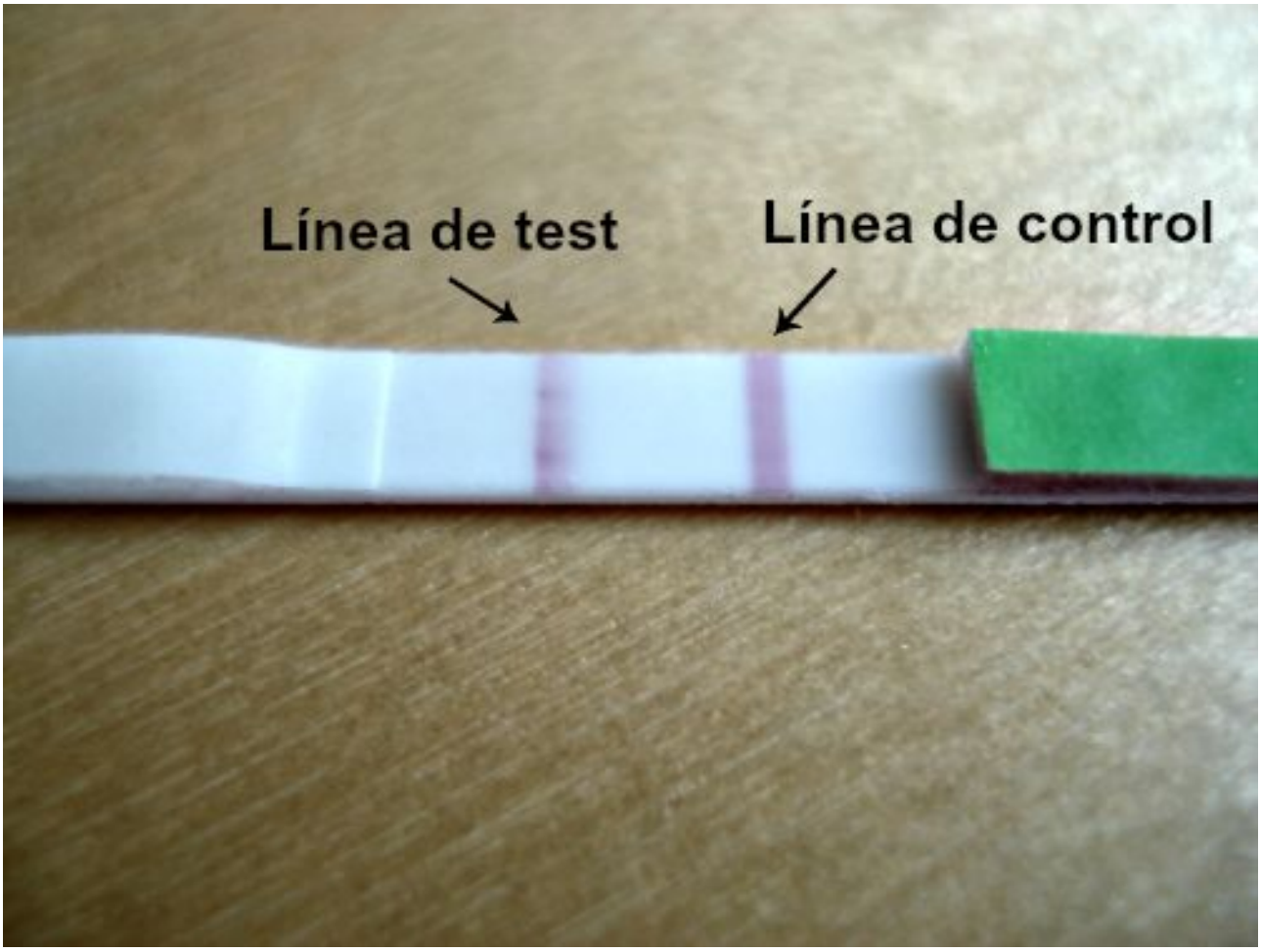
3.- **En los días que yo ya sabía que eran fértiles (en mi caso, no antes del día 16-17 del ciclo), me hacía tres test diarios** para poder detectar correctamente el pico de la hormona. **La línea seguía siendo de intensidad suave hasta que de pronto en uno de ellos aparecía mucho más marcada, tanto o más que la línea de control, es decir, positivo.**

Esta intensidad de la línea en mi caso se ha llegado a mantener hasta 36-48 horas pero en muchos casos no supera las 12.

4.- **A partir de ahí, la línea volvía a ser muy suave. En algunos casos desaparecía unos días y volvía a aparecer poco antes de la regla.** Este "volver a aparecer" unos días antes de la regla no quiere decir que el test fuera positivo, simplemente que la línea era perceptible sin dificultad, aún siendo negativo el test. Hay que considerar que si el test de ovulación fuera a predecir el embarazo, la línea empezaría siendo suave pero cada día iría siendo más oscura, hasta llegar a dar positivo, posiblemente un par de días antes de la menstruación. Si la línea es suave y se mantiene así día tras día, nos podemos olvidar de las ilusiones de ese mes.

Esto, como digo, es mi experiencia. Es más que probable que otras mujeres tengan otros patrones.

Mucha gente se confunde y piensa que el test de ovulación le da siempre positivo. A veces las ganas nos pueden.



Hay que tener muy presente, pero que muy muy presente, que **el test de ovulación positivo es aquel cuya línea de test es tan intensa o más que la de control**. Y esto, aunque nos parezca lo contrario, sucede tan sólo en un momento muy concreto del ciclo.

Entonces, ¿es normal o no que casi siempre salgan dos rayitas en un test de ovulación?

A la pregunta de si es normal que (casi) siempre aparezcan dos rayitas, **por lo que yo he podido averiguar: sí**.

La hormona que miden los test de ovulación, **la LH, se encuentra siempre presente en el ciclo de la mujer y funciona por oleadas**. Una de esas oleadas, la decisiva, es la que hará que el test de positivo y nos avisará de que la ovulación va a producirse de forma inminente.

El problema que tiene esto es que cuando te haces los test con ilusión y ansiedad, ver cualquier línea te pone un poco nerviosa y hasta que no llevas unos cuantos meses y has aprendido a conocer tu cuerpo, surgen dudas, sobre todo si se pretende usar el test de ovulación como anticipo del test de embarazo.

Por eso **siempre hay que tener cuidado con la interpretación de los test y, ante la duda, optar por la opción más conservadora**.

La línea de evaporación en los test de embarazo

La línea de evaporación en los test de embarazo es esa línea fantasma en una prueba de embarazo, que no se sabe *si sí o si no*, que según la mires parece que no hay nada o parece un positivo de verdad.

Una maldición de la que he sido *carne de cañón* de principio a fin.

Como buena adicta a los test de embarazo, he pasado horas y horas mirando y remirando los test con diferentes luces y ángulos tratando de ver un positivo que nunca existía.

Y como toda conducta compulsiva, terminé hacerlo a escondidas de mi marido, siendo consciente de que era un comportamiento obsesivo, absurdo y muy dañino para mi... pero que no podía dejar.

Sin embargo, en enero de 2009 este comportamiento compulsivo tuvo su recompensa. Me enteré de que estaba embarazada después de que un impulso totalmente irracional me obligara a rescatar un test de embarazo del cubo de la basura y mirarlo a la luz de la cocina.

A veces me pregunto si fue una buena manera o no de enterarme porque soy consciente de que ese hecho no hizo sino alimentar mi idea de que un test de embarazo puede dar positivo un buen rato después del tiempo aconsejado por el fabricante para interpretar el resultado.

Y esa idea es dañina porque aumenta la obsesión y porque en los test de embarazo existe la maldita línea de evaporación.

¿Qué es la línea de evaporación en los test de embarazo?

La línea de evaporación de un test de embarazo es una raya, marca o sombra que aparece en el test de embarazo que en principio era negativo, justo en el sitio donde debería haber aparecido la raya que nos diera el resultado positivo.

Como supongo que todos sabremos, para que un test de embarazo de positivo, deben existir dos líneas: la de control, que garantiza que el test está bien hecho, y la de test. En definitiva, deberíamos ver algo como la foto que ilustra este post.

La línea de test no tiene por qué estar muy marcada, una línea finita y muy débil es suficiente para confirmar el embarazo.

Conforme el embarazo vaya avanzando y pasen más días desde la falta de la regla, esa línea se irá haciendo más intensa, pero, como digo, con que sea visible aún dándose un golpe en un ojo el resultado es positivo.

Cualquiera esperaría que un test de embarazo negativo tuviera una única raya y el resto color blanco nuclear. Pues no, en muchos aparece una rayita microscópica que hace que una se suba por las paredes y llame a todo el vecindario para averiguar qué significa.

Los fabricantes de test, para curarse en salud, indican en sus folletos que los resultados deben siempre interpretarse dentro de un baremo de tiempo que suelen fijar en 10 minutos. Los resultados pasado ese tiempo deben desecharse.

En realidad, no es que un positivo que se obtiene a los 15 minutos no sea positivo, es que los fabricantes no quieren hablar de las espantosas líneas de evaporación que tienen muchos de sus tests, que aparecen pasado ese tiempo de rigor y que pueden llevar a muchas mujeres a interpretar sus test como positivos para después llevarse el disgusto de encontrarse con su periodo días más tarde.

¿Cómo distinguir una línea de evaporación de un positivo muy clarito?

La línea de evaporación es una maldición de la que se habla mucho en los foros pero de la que nunca he leído nada en ningún folleto, ¡qué curioso!
Distinguir la línea de evaporación de un positivo tardío puede llegar a ser muy complicado. **Se dice que las líneas de evaporación son de color gris (en lugar de rosa) mientras que las sombras de un positivo tardío deben ser rositas**. Pero lo cierto es que la diferencia entre ambos colores a menudo es casi imperceptible.

Después de haber visto muchas marcas de test, de farmacia y comprados online, he llegado a la conclusión de que todos, absolutamente todos, tienen línea de evaporación.

De hecho, en algunos test es tan evidente que si afinas un poco la vista puedes verla antes de hacerte el test.

Y es que, en muchos casos, la línea de evaporación es el surco que llevan las tiritas justo por donde debería salir el tinte que diera el positivo. Algo un poco chapucero, desde mi punto de vista.

Marcas de test de embarazo con menos línea de evaporación

Ni los test más caros se libran de esta línea aunque, como expliqué cuando comenté dónde comprar online test de embarazo y ovulación, algunas marcas padecen más de este problema que otras.

Así, la línea de evaporación de Unitest a mi me parece infame, en alguna ocasión he estado por empaquetar un test y enviárselo de vuelta para que me explicaran si les parecía normal.

En cualquier caso, tengo comprobado que estos test más baratos, aunque en cuanto a calibrado sean 100% fiables, presentan ciertos defectillos de fabricación. Por ejemplo, si los alineas, verás que cada uno tiene la marca de máximo a una altura. Y muchos de ellos tienen marcas en la superficie donde deben aparecer las rayas, incluso surcos horizontales, fruto sin duda de una mala manipulación del producto. Claro, por menos de un euro por test no podemos pedir gran cosa, pero influye en la facilidad de la interpretación, es innegable.

En cualquier caso, por relación calidad / precio, sin duda alguna me quedo con los test de embarazo One Step de Amazon.

No he sido capaz de hacer una buena foto ni de encontrar ninguna en la que se aprecie. Es una pena porque creo que sería útil poder mostrarlo pero carezco del objetivo necesario para poder captar algo tan sutil. Si habéis conseguido captar una, por favor, enviádmela y la pongo en este post para que nos ayude a todas.

¿Cómo combatir la línea de evaporación en los test de embarazo?

(Aquí es cuando doy consejos de esos que son buenísimos pero que yo nunca he aplicado ni aplicaré porque soy incapaz…)

La mejor manera de evitar esto es no hacer *early testing* y esperar pacientemente a la primera falta de la regla, además de usar la primera orina de la mañana (o al menos una suficientemente concentrada) y una vez obtenido el negativo tirar el test por la ventana, quemarlo o finiquitarlo de tal manera que sea imposible revisarlo cinco mil veces durante las siguientes 24 horas en busca de una raya que posiblemente no vayamos a ver en ese ciclo por más que nos empeñemos.

Lo que está claro es que la línea de evaporación llama a más líneas de evaporación. Cuando vemos una, nos repetimos el test a las pocas horas para comprobar qué había de cierto en nuestras sospechas.

Como obtenemos otra línea de evaporación, nos hacemos otro. Y otro. Y otro.

Si en ese momento pudiéramos vernos desde fuera sería fácil reconocer que cuando una línea no se hace más oscura ni más gruesa ni más nítida con el paso de las horas/días nunca podrá convertirse en un positivo.

Ese reconocimiento quizá sea el más duro, yo me he negado a él incluso con los primeros manchados de la regla, es más fácil engañarse con falsas líneas fantasma.

Entonces, ¿qué test de embarazo compro para evitar la línea de evaporación?

Tras haber probado decenas de marcas, tal y como os he dicho antes, yo sin duda me quedo con los test de embarazo One Step de Amazon. Tienen un precio estupendo, se pueden comprar en varios tipos de packs (incluso combinados con tests de ovulación) y, sobre todo, son los que menos problemas me han dado con las líneas de evaporación.

¿No quieres complicarte la vida? Prueba un test de embarazo Clearblue. A mi personalmente me encanta pasarme las horas muertas mirando los tests bajo diferentes luces y ángulos, pero si no quieres pensar en nada, los test de embarazo Clearblue son la mejor opción para ti ya que nunca verás la tira interior. El test "decide" por ti y te muestra en pantalla si estás embarazada o no.

Paciencia, amigas, yo una vez, después de un millón de desengaños, conseguí ver una línea que era de embarazo y, no, mis ojos esa vez no tuvieron que soportar otra línea de evaporación...

¿Cuándo podría dar positivo un test de embarazo de alta sensibilidad?

Seguro que más de una vez te has preguntado **cuándo podría dar positivo un test de embarazo**.

Sobre todo ahora que tenemos a nuestra disposición test de embarazo cuya sensibilidad es mucho mayor que los que conocíamos hasta hace nada, la **posibilidad de averiguar si estamos o no esperando un bebé cuando aún no hemos tenido ni la primera falta**... es muy tentador.

Sin dudar, conocer a **partir de qué día podrías hacerte un test de embarazo y tener opciones de que de positivo** es la pregunta del millón, ¿verdad? Cuantos desvelos, cuántos sueños... y cuántas frustraciones. ¡Qué anhelo tan grande el de conseguir un embarazo! Y cuantas horas invertidas mirando tests *al trasluz* esperando ver ese ansiado positivo…

Ya sabéis que **me apasiona la fertilidad**.

Llevo años utilizando el método sintotérmico.

Estudiando e investigando sobre el ciclo menstrual y, más en concreto, sobre **cómo maximizar las posibilidades de quedarnos embarazadas** simplemente conociendo nuestro cuerpo.

Como mujer, encuentro tan fascinante conocer mi cuerpo que me encantaría que todas las mujeres tuvieran oportunidad que conocerse así de bien.

Como ya comenté hace unos meses, cuando en 2011 iniciamos la aventura de intentar quedarnos de nuevo embarazados, quise aprovechar la ocasión para averiguar varias cosas que tenía pendientes con relación a los test de embarazo y de ovulación a los que he sido siempre tan aficionada.

Así pude obtener la respuesta a estas dos preguntas que muchas seguro que os hacéis:

- En mis dos embarazos el test de ovulación adelantó el positivo por embarazo y

- Que es de lo más normal que se obtengan siempre dos rayitas al hacernos un test de ovulación, puesto que la hormona que mide está siempre presente en mayor o menor medida a lo largo del ciclo menstrual.

Me faltaba resolver una tercera curiosidad: **cuándo podría obtener un positivo en un test de embarazo de alta sensibilidad**.

Esta cuestión es la que resuelvo hoy en este post.

Porque **saber cuándo puedes hacerte un test de embarazo y tener posibilidades de que de positivo no es un asunto *baladí***. No es sólo que la economía no está para gastar y gastar test de embarazo *a lo loco* (que algunas de esto sabemos un rato). Es que el desgaste emocional que produce cada negativo es un fuerte impacto para nuestro ánimo.

Tu estás con tu gran ilusión, sintiendo ya toda clase de **síntomas de embarazo**, imaginándote con tripita dentro de apenas unas pocas semanas... Y gastando test uno tras otro para que una y otra vez arrojen un resultado negativo. Lo he vivido y no te lo recomiendo.

Así que vamos a resolver hoy **a partir de qué día podríamos hacernos un test de embarazo y tener opciones de encontrarnos con dos rayitas en la ventana del test**.

Pero antes de contaros los resultados de mi investigación, vayamos por partes...

Cuándo podría dar positivo un test de embarazo de sensibilidad estándar

Los test de embarazo normales o estándar son de sensibilidad 25 mUI/mL.

Este tipo de pruebas de embarazo caseras son las que se venden habitualmente tanto en las farmacias como en Internet.

En muchos centros médicos (por ejemplo, en mi ambulatorio) la sensibilidad que usan es aún peor, de 50 mUI/mL.

Normalmente, un test de embarazo de sensibilidad 25 dará positivo el primer día de la falta de la menstruación, mientras que uno de sensibilidad 50 podría tardar varios días, incluso más de una semana.

No sé por qué se siguen utilizando pero... ahí están. Conozco muchos casos en los que no han obtenido un test de embarazo positivo en su médico de cabecera hasta pasado un mes de la primera falta. De hecho, en estos casos la forma más rápida y eficaz de confirmar que el resultado era positivo ha sido hacer una prueba de embarazo en sangre en lugar de la tradicional prueba con la orina.

Cuándo podría dar positivo un test de embarazo de alta sensibilidad

Los test de embarazo más sensibles son los llamados de **tests alta sensibilidad, capaces de detectar la hormona del embarazo desde 10 mUI/mL**.

Lo mejor es comprarlos por Internet ya que no son fáciles de encontrar en las farmacias. Podéis preguntar por la marca Lisubel, pero lo tienen en muy pocas farmacias y además sale bastante más caro.

Los test de embarazo de alta sensibilidad en Amazon salen muy bien de precio y son de muy buena calidad.

Estas pruebas de embarazo de alta sensibilidad podrían dar un positivo temprano, varios días antes de la no llegada de la menstruación.

Si quieres conocer el resultado de si estás embarazada o no antes de la primera falta, esta opción es mucho más aconsejable que los test de embarazo tradicionales que te mencionaba en el apartado anterior.

Cuándo podrías tener un resultado positivo un test de embarazo ultrasensible

Desde hace muy poquito podemos comprar un nuevo tipo de test: los **test de embarazo ultrasensibles**.

Este tipo de test de embarazo ultra sensible es capaz de detectar la hormona del embarazo desde 5 mUI/mL.

Si los test de embarazo de alta sensibilidad ya son difíciles de encontrar en las farmacias, estos ya directamente nos olvidamos en tiendas físicas.

El test de embarazo ultrasensible que yo conozco es de ABBLO Pharma y se compra en Amazon (y además cuesta menos de 9 euros).

Estos test de alta sensibilidad prometen detectar la hormona del embarazo varios días antes de la primera falta. Apenas unos pocos días después de la concepción y posterior implantación. Es decir, mucho antes de que tan siquiera nos planteemos que tenemos un *retraso*.

La cuestión es: ¿cuántos días antes podemos hacernos uno de estos test para confirmar de forma fiable si estamos embarazadas?

Mi experiencia buscando el positivo temprano en un test de embarazo

Para averiguar cuándo podría dar positivo un test de embarazo casero, los meses que estuvimos buscando el embarazo empecé a hacerme estos tests de alta sensibilidad (10 mUI/mL) desde el día 5 post ovulación.

Ni qué decir tiene que el día 5 de la fase lútea es imposible que pudieran dar positivo, pero pensé en hacerlo así para llegar a tiempo a observar la más mínima rayita color rosa que pudiera salir y no fuera una línea de evaporación.

23 de agosto, día de mi cumpleaños, noveno día post ovulación. Me hago un test de embarazo, como todos los días, después de comer. Si, ya sé que lo indicado es con la primera orina de la mañana, pero llevaba una racha durmiendo muy mal y levantándome a hacer pis muchas veces durante la noche, así que decidí hacerlo después de comer.

Resultado: test en blanco, negativo. Lo cierto es que me pareció que por unos segundos se veía una rayita rosa pero desapareció en cuestión de décimas de segundo.

Tiro el test a la basura y me olvido del tema.

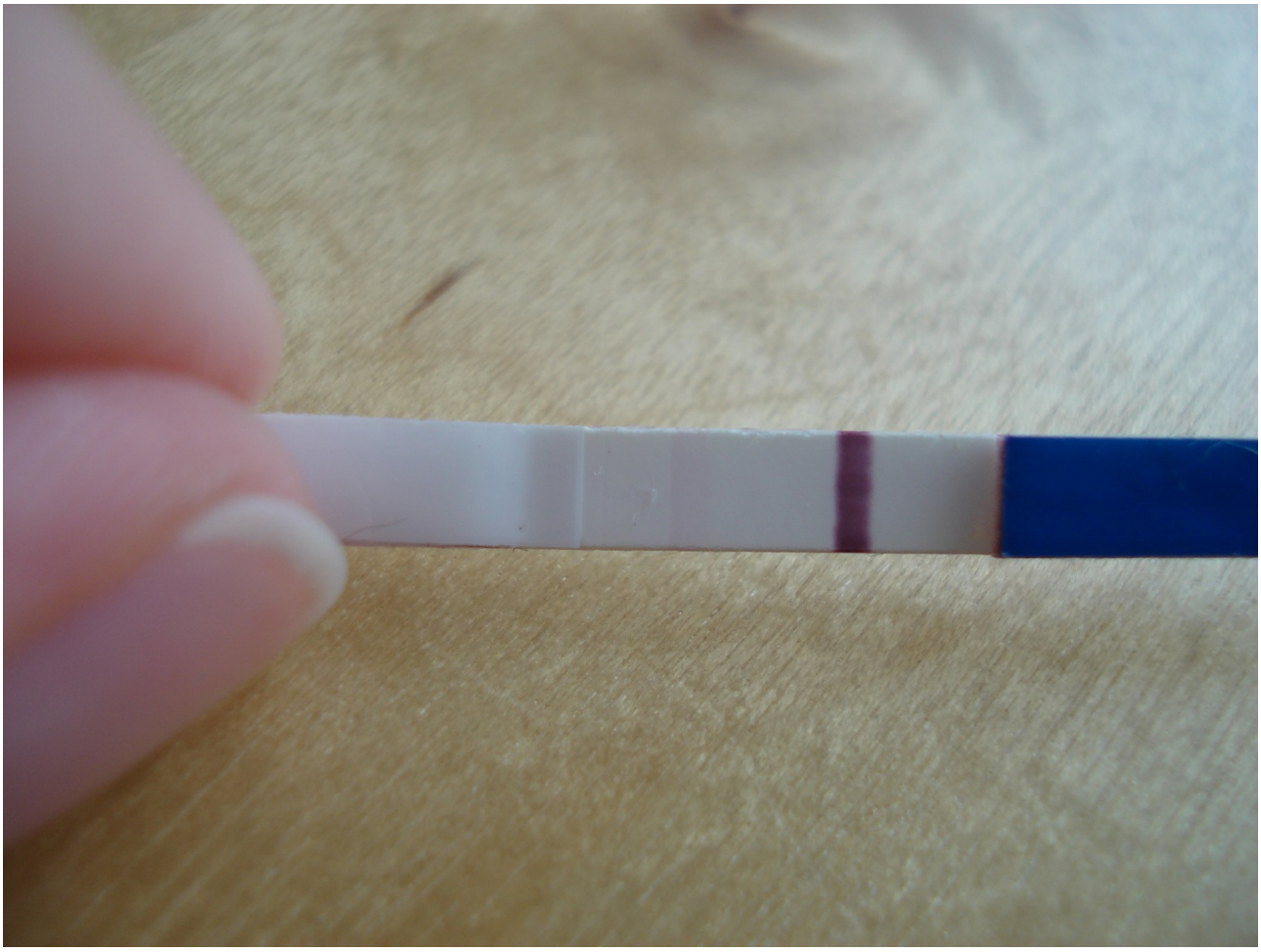
Me pongo triste, sí, me parecía un buen regalo de cumpleaños obtener un positivo. Muy buen regalo estar esperando otro bebé.

Recuerdo que me dije: *bueno, por lo menos sigo adelante con mi investigación acerca de cuándo podría dar positivo un test de embarazo casero*.

Y al mismo tiempo decido tirar la toalla: *este mes tampoco será nuestro mes, hay que asumir que no será fácil quedarme embarazada de nuevo*.

24 de agosto, décimo día post ovulación. Si mis ciclos fueran de 28 días, me tendría que venir la regla. Pero como mis ciclos son de unos 31-32 días, no espero la regla hasta el día 27-28.

Me hago un test de embarazo después de comer con bastante poco entusiasmo. Y casi me da un soponcio cuando veo esto, ¡no me lo esperaba para nada!



Test de embarazo de alta sensibilidad positivo

En la imagen parece algo más débil pero en persona, aún siendo una rayita suave, se apreciaba perfectamente y desde los primeros segundos de haber hecho el test.

Por la tarde corroboré el positivo con otro test.

Conclusión: ¿Qué día podría hacerme un test de embarazo y tener opciones de ver dos rayitas?

En mi caso, un test de embarazo de alta sensibilidad puede dar positivo en el décimo día post ovulación, es decir, unos tres o cuatro días antes de la primera falta.

¿Y si me hago un test de embarazo antes de tiempo?

Si te pasa lo mismo que a mi y no puedes esperar, lo único que vas a conseguir es una única línea marcada en la ventanita del test: la que confirma que lo has hecho bien. Es decir, un negativo *como una casa*.

Si te haces un test de embarazo casero antes de tiempo y da negativo, no quiere decir que no estés embarazada. Puede ser, simplemente, que sea demasiado pronto para que el test pueda dar positivo porque el embarazo es muy incipiente. O que el test de embarazo que hayas elegido no tenga sensibilidad suficiente para detectar la cantidad de hormona gonadotropina coriónica que tienes en ese momento en tu cuerpo. O una combinación de ambas: es demasiado pronto y el test es poco sensible.

Esto es lo que se conoce como **falso negativo**. Y lo único bueno que tiene es que, al final, sí que estás embarazada y tarde o temprano conseguirás verlo en un test de embarazo.

Saber Más | ¿Cómo interpretar un test de embarazo? | ¿Cuándo puedo hacerme un test de embarazo? | ¿Dónde comprar test de embarazo y ovulación online? | Test de embarazo en sangre: niveles de beta hcG

Patrón espermático (o cada cuánto hacerlo para concebir)

Una de las recomendaciones más frecuentes cuando estás intentando concebir es la de evitar tener relaciones diariamente y alternarlas o, incluso, dejar un tiempo de abstinencia de dos o tres días entre cada coito. Este criterio no sólo es algo que está muy extendido entre *el pueblo* sino que la comunidad médica (urólogos, ginecólogos) lo repite una y otra vez. Nuestro caso no fue una excepción: siempre nos insistieron en que hacerlo a diario era perjudicial.

Yo, que soy cabezona por naturaleza, no podía entender una recomendación semejante. Sin ser especialista, mi sentido común me decía que cuántas más relaciones, más posibilidades. Más coitos igual a mayor número de espermatozoides y a mayor número de espermatozoides más posibilidades de que alguno alcance la meta.

¿Por qué entonces el sentido común y el criterio médico no coinciden? Mi opinión personal es que muchos médicos utilizan criterios basados en estudios poco actualizados. O con intereses no muy claros. Tristemente, detrás de la infertilidad hay un negocio muy fructífero.

Me da la impresión de que sucede algo parecido al tema del método sintotérmico: es un método científico, altamente eficaz para conocer el ciclo de la mujer, fantástico para focalizar los días en que deben redoblarse los esfuerzos para obtener un embarazo y, sin embargo, no es que haya una gran mayoría de médicos que lo desconocen, no, es que hay muchísimos médicos que, conociéndolo, lo desprecian.

Como digo, soy muy cabezona. Y cuando me pongo burra me da por leer e informarme. Y cuando una se informa, a veces obtiene respuestas que nadie le ha dado en persona. Por ejemplo, encontrando estudios que dicen justamente lo que mi sentido común indica: que para muchos hombres el hecho de tener relaciones a diario no sólo no sería perjudicial sino que sería beneficioso. El estudio, por cierto, es de David Greening, reputado especialista en fertilidad, de IVF Australia, en Sydney.

Aquí es cuando entra en juego un término del que no se habla mucho pero que es básico: **patrón espermático**. Significa que los espermatozoides tienen un ciclo vital dentro de los testículos que difiere de un hombre a otro, al igual que las mujeres tenemos ciclos menstruales que difieren de unas a otras y que, de hecho, muchas veces no son contantes de un ciclo a otro.

Para algunos hombres, una abstinencia de varios días puede significar que en el momento de eyaculado haya muchos más espermatozoides (mayor volumen, se dice) y una calidad constante. Sin embargo, otros hombres, con la misma abstinencia, aun cuando efectivamente eyacularan mayor cantidad de espermatozoides, estos podrían estar más dañados, más deteriorados (lo que yo llamo *sobrecocidos*).

Tradicionalmente se ha estimado que eyacular a diario producía, además de unas eyaculaciones de menor volumen, unos espermatozoides mucho más inmaduros, no preparados para fecundar el óvulo. Ahora, existen estudios que han sugerido que en hombres con alto recuento de espermatozoides anormales, eyacular a diario mejoraría el conteo de espermatozoides normales por la renovación que eso produce.

A mi me modo de ver, esto cambia bastante la perspectiva. Lo ideal, probablemente, sería conocer qué patrón tiene ese hombre que tiene un seminograma *malo* para averiguar si le favorece una mayor renovación espermática o, por el contrario, tener un esperma más maduro. No sé si esto se hace en la práctica, creo que no. Al menos a mi no me han llegado noticias de que a ningún hombre se le haya propuesto hacer un seguimiento de este tipo (que realmente sería sencillo haciendo un seminograma diario durante una semana y después un seminograma cada tres días hasta completar siete eyaculaciones, digo yo).

Mi experiencia personal me lleva a apoyar la tesis de las relaciones diarias. Nosotros nos quedamos embarazados un mes en el que lo hicimos todos los días dentro del periodo fértil, incluso más allá del segundo día de subida de temperatura. ¿Casualidad? Nunca lo sabremos.

Mi opinión es clara. Creo que cada pareja debe adoptar la fórmula que mejor le convenga y apetezca y dejarse de consejos que, probablemente, no se sostienen en una evidencia científica clara, pues esta sólo podría venir dada por el estudio pormenorizado del patrón espermático del varón y no por un criterio genérico.

¿Se puede elegir el sexo del bebé?

Al hilo de mi entrada sobre si los test de ovulación adelantan el positivo por embarazo, me preguntaban cuál era mi opinión sobre si se puede elegir o no el sexo del bebé programando las relaciones.

Antes de nada, un poco de ciencia. El sexo del bebé es determinado por el espermatozoide que fecunda el óvulo. Los ovocitos sólo pueden llevar el cromosoma X mientras que los espermatozoides pueden aportan X o Y. Los espermatozoides portadores de la X darían lugar a bebés niña y los portadores del cromosoma Y darían lugar a niños. En mi lenguaje de andar por casa, esto significa que hay *espermatos macho* y *espermatos hembra*.

Se sabe que los espermatozoides macho son más rápidos pero mueren antes. Los espermatozoides hembra son más lentos pero viven bastante más tiempo. Al parecer esto se debe, literalmente, al tamaño del cromosoma, siendo el Y más pequeño y, por tanto, más ligero.

Por otro lado, la vida del óvulo es muy corta, 24 horas como mucho, probablemente sólo unas 12 horas en condiciones de ser fecundado.

Si juntamos las evidencias sobre la velocidad y supervivencia de los espermatozoides con la corta vida que tiene el óvulo en las trompas de la mujer, ahí tenemos la aparición de las teorías acerca de cómo programar las relaciones para tener niño o niña, según queramos.

Siguiendo un razonamiento lógico, si lo que queremos es tener un niño, debemos tener relaciones sexuales justo en el momento de la ovulación. Los espermatozoides Y subirán rápidamente, encontrarán al óvulo y lo fecundarán en un pis pas. Si lo que queremos es tener una niña, las relaciones deberían tenerse varios días antes de la ovulación, para dar tiempo a que los espermatozoides hembra puedan ir subiendo al encuentro del óvulo y, de paso, mueran todos los espermatozoides macho, que en condiciones de igualdad son serios competidores por lo rápidos que son.

Es probable que muchos hayáis oído hablar del ***método Baretta***, en la red se habla mucho de él y existe un libro. Parte de esta teoría, que es muy lógica, para añadirle algunos *complementos*, el más conocido de ellos acerca del moco cervical de la mujer. El moco cervical es el medio conductor de los espermatozoides en su camino hacia el óvulo, siendo muy difícil su supervivencia y desplazamiento sin su presencia. Al parecer, a los espermatozoides macho les favorece el medio alcalino y a los espermatozoides hembra, el salino. Según esta doctora, mediante la dieta se puede modificar ese medio y, por tanto, seleccionar a los espermatozoides que se verán favorecidos por él.

Revisando mi alimentación desde su punto de vista, mi gusto por la comida basura podría permitirme tener sólo niños, algo que, de momento, se ha cumplido.

A mi todo esto me apasiona casi al mismo nivel al que le tengo mucho respeto. Creo que jugar a ser Dios es algo peligroso y siendo supersticiosa como soy, creo que confiar mucho en estas cosas puede terminar mal… Pero entiendo que cada cual es libre de aplicar las teorías que le parezcan.

A lo largo de estos años en los que me he ido empapando de estos temas y preguntando a la gente que me ha querido contar su experiencia, sí he podido comprobar que la teoría se cumple en muchos casos, pero nunca en todos. De este modo, las personas que hemos tenido dificultades para quedar embarazados y hemos terminado *dándole al tema* todos los días y a todas horas, hemos tenido más niños. Las personas que han tenido *accidentes* y/o pocas relaciones durante el mes, sin hacer ni caso a la ovulación ni nada por el estilo, han tenido más niñas.

Pero, como digo, esto es cuestión de probabilidades y también conozco casos de niñas concebidas en el mismo día de la ovulación. ¡Nada es imposible!.

A través de una amiga he oído hablar de una persona que aplicó el método Baretta a rajatabla para tener una niña (dieta varios meses antes, un único coito en todo el mes varios días antes de la ovulación, etc). El resultado se llama Sergio.

No me parece nada raro, Internet está lleno de testimonios de gente que afirma haber estado en la consulta de esta doctora y han tenido hijos del sexo contrario al que esperaban. Y es que, salvo implantación de un blastocito de un sexo ya comprobado en laboratorio, lo que pasa ahí dentro de forma natural es un proceso que no podemos ver ni controlar sino solamente imaginar.

Hay una cosa que sí creo a ciencia cierta: que este tipo de *estratagemas*, casi siempre destinadas a traer niñas a este mundo, es para parejas con buena fertilidad. La recomendación de abstenerse de tener relaciones, pongamos, tres días antes de la ovulación para garantizarse una nena puede estar muy bien para esos hombres que tienen un esperma estupendo y unas mujeres hiper fértiles. A nosotros no se nos ocurriría ni locos tener una abstinencia semejante, mi hijo seguro que no estaría en este mundo y no sé si alguna vez hubiéramos logrado embarazarnos. Por tanto, método no apto para parejas que andan regulín regulán ni para impacientes ni para parejas a los que la edad se les echa encima.

Por otro lado, acertar con la ovulación no es sencillo. Después de unos cuantos meses realizando el sintotérmico y controlando bien el propio cuerpo, acompañándolo de test de ovulación si se quiere, se puede llegar a detectar con relativa facilidad pero nunca con exactitud. Además, programar relaciones no siempre es sencillo, la vida que llevamos no lo favorece.

Una última cosa: hay hombres que tienen más dañado el esperma de un tipo que de otro. Y mujeres con un tipo de moco cervical que efectivamente es hostil a un determinado tipo de espermatozoide (o, lamentablemente, a ambos tipos). Esto podría explicar, seguramente, que haya familias que hagan lo que hagan siempre tendrán niños o siempre tendrán niñas.

Mi opinión, por tanto, es la siguiente: se puede favorecer uno u otro sexo teniendo en cuenta las consideraciones que he expuesto pero nada puede garantizar el sexo del bebé y, desde mi punto de vista, mejor así.

Embarazo: cuentas oficiales y cuentas propias

Cuando te quedas embarazada, la primera pregunta que te hace tu obstetra es la fecha de tu última regla: la famosa **FUR**. En base a esta fecha se establecerán todos los cálculos del embarazo: ese será el primer día de la gestación y será el que determine cuál es la fecha prevista de parto (**FPP**). **Este *cálculo oficial* se hace considerando que todas las mujeres tenemos ciclos de 28 días, en los que la ovulación se ha producido más o menos sobre el día 13 ó 14 del ciclo**. Es decir, que el día en que te tenía que venir la regla, tomando como base un ciclo de 28 días, se considera que estás de 4 semanas, aunque realmente las dos primeras correspondieran a una fase pre-ovulatoria.

Desconozco cómo se llegó a esta convención obstétrica. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de nuestras madres (por no decir todas) no habían oído hablar de estos cálculos durante sus embarazos y se organizaban en base a las *faltas* (meses sin menstruación), lo que me hace pensar que es algo relativamente reciente. Entiendo que si se cambió de sistema es porque éste resultaba más preciso; sin embargo, como ningún sistema es perfecto, presenta algunos problemas.

El más evidente es **dar por hecho que todas las mujeres tenemos ciclos de 28 días y ovulamos en torno al día 13 ó 14 del mismo**. Si hiciéramos una encuesta entre mujeres que realizan el método sintotérmico de forma habitual, veríamos que muy **pocas responden a este patrón**. Incluso entre mujeres con ciclos regulares de 28 días exactos, muchas no ovularían en esos días, sino unos pocos días después o quizá incluso algún día antes, teniendo unas fases lúteas más o menos largas con respecto a estas estandarizadas.

Por otro lado, **el control que se tiene hoy día respecto del ciclo menstrual femenino es bastante más pobre que el que se tenía hace décadas**. Estas mujeres que organizaban sus embarazos en *faltas*, tenían muy claro qué día habían tenido su último periodo, incluso muchas, sin sintotérmico ni nada, conocían cuándo ovulaban. La *sabiduría popular*, que se dice, de la que dependía en muchos casos el control de la natalidad de esa familia. **Ahora, muchas tienen dudas sobre cuándo han tenido su última regla**, pues no es un dato importante de cara a la contracepción con los métodos que existen hoy día. Yo misma, cuando empecé a buscar el embarazo de mi primer hijo, no tenía claros ni los rudimentos más básicos de la fertilidad femenina y pensaba, por ejemplo, que todos los días eran igual de fértiles en un ciclo, confundía mis habituales manchados pre-ovulatorios con la regla… Si por aquel entonces me hubiera quedado embarazada y hubiera tenido que determinar cuál era mi FUR, es muy posible que me hubiera equivocado.

El avance en los métodos ecográficos hace que en algunas gestaciones se module la FPP en función de los datos obtenidos, cuando el bebé resulta ser (bastante) más grande o (bastante) más pequeño de lo que el sistema considera que debe ser. Aunque esto se haga con la intención de lograr una mayor exactitud, **en algunos casos corresponderá a la realidad y en otros no**. Habrá casos en los que la madre, efectivamente, se haya equivocado dando su fecha de último periodo y, por tanto, la ecografía realmente muestre con más precisión en qué momento de la gestación se encuentran.

Sin embargo, conociendo el día exacto de la ovulación, la ecografía podría mostrar bebés que crecen más o menos deprisa pero no se movería la FPP porque no habría ninguna duda al respecto de la fecha y quedaría claro que la variación de tamaño respecto a la media se debe a la genética, al entorno uterino, etc etc.

Desde mi punto de vista, lo importante sería decidir **qué importancia tiene esta falta de precisión**. Si yo tuviera que contestar diría: depende.

Si el parto se desencadena de forma natural, la importancia es nula. Aunque no está del todo claro hoy día por qué se desencadena el alumbramiento, los estudios parecen indicar que es el bebé el que *avisa* de que está listo para nacer y, por tanto, llega al mundo justo en el momento en que está totalmente preparado para ello. Así que en estos casos da exactamente igual si las cuentas oficiales dicen que el niño nació en la semana 39 cuando realmente era la 38, **el bebé nació** *cuando tenía que nacer*.

Sin embargo, algunos partos son inducidos o son cesáreas programadas, lo que significa que se elige una fecha para traer al bebé al mundo. Y esa fecha se escoge, casi siempre, atendiendo a los **cálculos oficiales**. Aquí es donde la falta de precisión puede tener cierta importancia. **El cálculo oficial puede determinar que el embarazo está ya a término** y que, por lo tanto, se puede practicar la intervención. Sin embargo, en una mujer de ciclos largos (como es mi caso), **el desconocer o no atender a las cuentas no oficiales puede suponer que el bebé nazca antes de estar a término**. Normalmente esto no tiene ninguna consecuencia pero podría traer algún problema al recién nacido que se pudiera haber evitado llevando unas **cuentas propias,** más precisas.

En mis dos embarazos he llevado esas dos cuentas distintas: las cuentas oficiales, que consideraban que yo tenía unos ciclos de 28 días que no he tenido jamás, y mis cuentas propias, adaptadas a los datos arrojados por el sintotérmico en el mes que me quedé embarazada. Teniendo ciclos largos y no del todo regulares, mis cuentas señalaban que había ovulado en torno al día 20 del ciclo y que, por lo tanto, el bebé tenía casi una semana menos de lo indicado por el cálculo oficial en el caso del Mayor y en torno a 4 días en este embarazo.

En mi caso, tiene poca importancia. Cuando elegí a mi actual ginecólogo, hace ya años, una de las cosas que más agradaron era que mirara mis gráficas del sintotérmico y las tuviera en cuenta. Curiosamente, en la clínica de ecografías a la que he acudido esta vez, en cada ecografía me han preguntado qué tipo de ciclos suelo tener, para tenerlo también en consideración. Una grata sorpresa, pues cuando hace años buscaba ginecólogo que averiguara por qué no conseguíamos quedarnos embarazados, era mencionar el sintotérmico y recibir respuestas de todo tipo menos de interés.

Mi humilde punto de vista es que cuando se tienen estos datos y el entorno médico los valora, todos ganan: el obstetra, obteniendo una información más precisa; el bebé, porque si tiene que salir antes al mundo, lo hará en el mejor momento posible (dentro de que no sea el día en que le tocaba) y, la madre, porque estará tranquila por su hijo y además sentirá que se la valora y se la tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones.

¿Síntomas de embarazo?: Todos… ¡o ninguno!

A raíz de una conversación que tuve ayer por twitter, me quedé pensando en lo relativo que es esto de los síntomas de embarazo. Basta que una mujer diga que tiene ganas de devolver, o que se encuentra mareada, para que todo el mundo diga el famoso "*uuuuuuuyyy, ¿no estarás embarazada?*".

Estoy segura de que la frase "síntomas de embarazo" es una de las más buscadas en Google en esta materia. Miles de mujeres (millones incluso) buscan diariamente información en la red, desesperadas por confirmar que esas sensaciones que tienen son efectivamente de embarazo o todo lo contrario. Pero, ¿existen realmente unos síntomas oficiales? ¿todos los síntomas de embarazo son exclusivos de esta situación fisiológica y no de otras situaciones?.

Yo no me atrevería a contestar, jamás de los jamases, cuáles son los síntomas de estar embarazada. A pesar de haber tenido un hijo, mi respuesta sería "*puff, no tengo ni idea*". Me podrían preguntar…

¿No es cierto que las ganas de devolver sean síntoma de embarazo? Las ganas de devolver, efectivamente, son uno de los síntomas más comunes, junto con los vómitos en sí mismos. Pero muchas mujeres con síndrome premenstrual también los padecen. Pueden ser achacables también, por qué no, a una astenia primaveral, a una gastrointeritis o simplemente ser psicológicos por estar nerviosas, sometidas a una situación de estrés…

Y el mareo, ¿el mareo no se produce muy a menudo en embarazadas?. Es muy común que durante el embarazo se produzcan mareos, por los cambios en la circulación sanguínea, siendo frecuentes las bajadas de tensión. Pero mujeres como yo, de tensión baja habitual, sabemos de sobra que estar mareada forma parte de nuestras vidas y no tiene nada que ver. Puede ser que un día hayas bebido poco y estás mal hidratada, puede ser que te esté rondando una enfermedad, puede ser de nuevo la astenia primaveral, puede no ser nada en concreto…

Tengo tensión en el pecho, ¿estaré embarazada?. No necesariamente. Antes de quedarme embarazada, tenía tensión en las mamas todos los meses. Y todos los meses me venía la regla, hasta que no me vino.

Se me ha hinchado mucho la tripa, tengo un tripón del 15, creo que estoy embarazada. La retención de líquidos y la hinchazón de tripa no quieren decir nada. Son dos trastornos muy comunes en las mujeres. Yo los he padecido durante muchos años y, como digo, me costó mucho conseguir un embarazo. Si hubiera tenido que fiarme por este síntoma, hubiera estado embarazada todos los meses.

Me noto muy cansada, sin fuerzas. Nunca me había encontrado así, creo que puede ser un síntoma. Desde luego, los primeros meses de embarazo a mi me produjeron una sensación de ir flotando todo el día, de estar desinflada, que es muy característica, es una sensación muy peculiar. Pero el cansancio en sí, tener sueño, sentirse débil, es solamente una muestra de agotamiento, que bien puede deberse a estrés de conseguir un embarazo o a cualquier otra situación física (nuevamente mi querida astenia primaveral, por ejemplo).

Desmontar la teoría de los síntomas de embarazo me da penilla, pero es lo que pienso. Cuando estás buscando un embarazo, o simplemente sospechas, estás deseando observar cada poro de tu cuerpo en busca de la respuesta, pero el cuerpo de la mujer es muy complejo y no nos podemos fiar. Lo único que puede confirmar un embarazo es un test positivo o una ecografía. Mientras tanto, lo único que se puede hacer es esperar e intentar no comerse mucho la cabeza… ¡Difícil tarea!.

Test de embarazo en sangre: niveles de Beta hCG

Si estás buscando un bebé, seguro que ya conoces que **el test de embarazo en sangre mide los niveles de beta hCG presentes en el cuerpo de la mujer**.

Ya se puede comprar un test de embarazo ultrasensible, que permite detectar si estás embarazada desde tan sólo 5 mIU/mL.

Con este tipo de tests podríamos obtener un positivo apenas 8-10 días después de haberse producido la fecundación. O lo que es lo mismo, varios días antes de la primera falta de menstruación.

Pero, además de los clásicos test de orina, existe otra forma de **averiguar si estás embarazada o no: con un test de embarazo en sangre**.

Test de embarazo en sangre

El test de embarazo más extendido es el de orina, ya que permite conocer si estás embarazada o no de una forma muy rápida y económica, y en tu propia casa.

Pero es muy habitual que al acudir al médico para un primer control, nos pida un test de embarazo en sangre.

Con el test de embarazo en sangre podremos confirmar si efectivamente estamos embarazadas o no y comprobar si todo está correcto.

Recordemos, además, que cuando el embarazo está en una fase muy inicial no podremos ver nada en una ecografía. La prueba en sangre sería la forma más precisa para confirmar si estamos gestando o no.

Yo me los hice en ambos embarazos. ¿Por qué? Pues porque como yo he practicado el *early testing*, la única forma de confirmar un embarazo tan temprano era mediante un análisis de sangre.

¿Qué es la hormona hCG y por qué la llaman hormona del embarazo?

El nombre técnico es **beta hCG o hormona gonadotrofina coriónica humana.**

Un término verdaderamente complicado que sin embargo no hay embarazada que no conozca, ya que podríamos llamarla "**la hormona del embarazo**".

La beta hCG se produce en el cuerpo de la mujer una vez que ha habido fecundación, desde el momento en que el embrión se ha implantado en el útero.

Gracias a la acción de la hormona hCG se obra un verdadero milagro:

- Se mantiene el cuerpo lúteo al comienzo del embarazo, para permitir que el embrión vaya creciendo.
- Se segrega progesterona, otra hormona fundamental para que todo vaya bien.
- Se evita que el cuerpo de la madre rechace al bebé que se está gestando.

Cuáles son los niveles de beta hCG en el embarazo

Los márgenes pueden variar según el laboratorio y el médico que los interprete.

Yo he rescatado los niveles que me ponen en los test de embarazo en sangre que me realicé en mis dos embarazos.

Para que tengáis una orientación, los valores de referencia de beta hCG en el embarazo serían:

Embarazo 1-2 semanas: 5-120 mUI/ml.
Embarazo 2-4 semanas: 13-1.175 mUI/ml.
Embarazo 4-6 semanas: 45-80.500 mUI/ml.
Embarazo 6-16 semanas: 2.600-175.304 mUI/ml.
Embarazo >16 semanas: 21.160-65.730 mUI/ml.
Segundo trimestre: 10.000 y 30.000 UI/ml
Tercer trimestre: 5.000 a 14.000 UI/ml

Normalmente en torno a la semana 10 de embarazo se daría el pico más alto de hormona hCG. A partir de ahí irían bajando hasta la semana 20 para luego estabilizarse hasta el momento del parto.

Aunque estas tablas puedan serviros de orientación, lo más importante desde luego es la interpretación que le de vuestro ginecólogo.

Además de los niveles que muestre el test de embarazo en sangre hay un dato muy relevante: **en las primeras semanas de embarazo, los niveles de beta hCG se doblan cada 2-3 días.**

Cuándo daría positivo un test de embarazo en sangre

Cada laboratorio y cada ginecólogo manejará unas tablas.

Normalmente el baremo suele ser éste:

- Beta hCG < 5 mIU/ml = resultado negativo. No habría embarazo.

- Beta hCG entre 5 y 25 mIU/ml = resultado dudoso. Podría haber embarazo pero el resultado no es concluyente porque quizá se haya hecho la prueba demasiado pronto. Es aconsejable repetir el test en unos días.

- BhCG > 25 mIU/ml = resultado positivo. ¡Bebé en camino!

Niveles de beta hCG en embarazos múltiples

Si los niveles de beta hCG de tu prueba son muy altos, es posible que estés embarazada de más de un bebé.

Al parecer, en embarazos múltiples la hormona hCG puede tener valores hasta 30-50% más elevados de los que se registran en un embarazo de un sólo bebé.

¿Puede haber un falso negativo en un test de embarazo en sangre?

Si te has hecho la prueba demasiado pronto, sí, puede haber un falso negativo en un test de embarazo en sangre.

Yo, que he sido la loca de los tests, tenía un lema: **hasta que no viene la regla hay esperanza**.
Es muy posible que no hayas tenido el ciclo que creías haber tenido, por ejemplo puedes haber ovulado más tarde.

Así que podías estar embarazada y simplemente te has hecho el test demasiado pronto.

Si no te viene la regla en unos días, seguro que tu médico te manda otro análisis.

¿Puede darse un falso positivo en un test de embarazo en sangre?

Sería bastante raro.

Si se obtiene un positivo pero posteriormente se confirma que no hay un embarazo, podríamos estar ante un caso de un aborto muy temprano, lo que muchas veces tristemente se ha llamado "micro aborto" (como si por *micro* fuera a doler menos, ¿verdad?).

En estos casos, la hormona hCG iría disminuyendo con el paso de los días.

Muy infrecuentemente, podría darse un caso de falso positivo en algunos casos de mujeres cerca de la menopausia, personas que han tenido la mononucleosis hace poco o si existen ciertos tumores.

Espero que os haya resultado útil esta información sobre los **test de embarazo en sangre y los niveles de referencia de beta hCG en el embarazo**. Ya sabéis que quien mejor os puede asesorar y cuidar es vuestro ginecólogo. ¡Mucha suerte en la búsqueda!

Recursos útiles



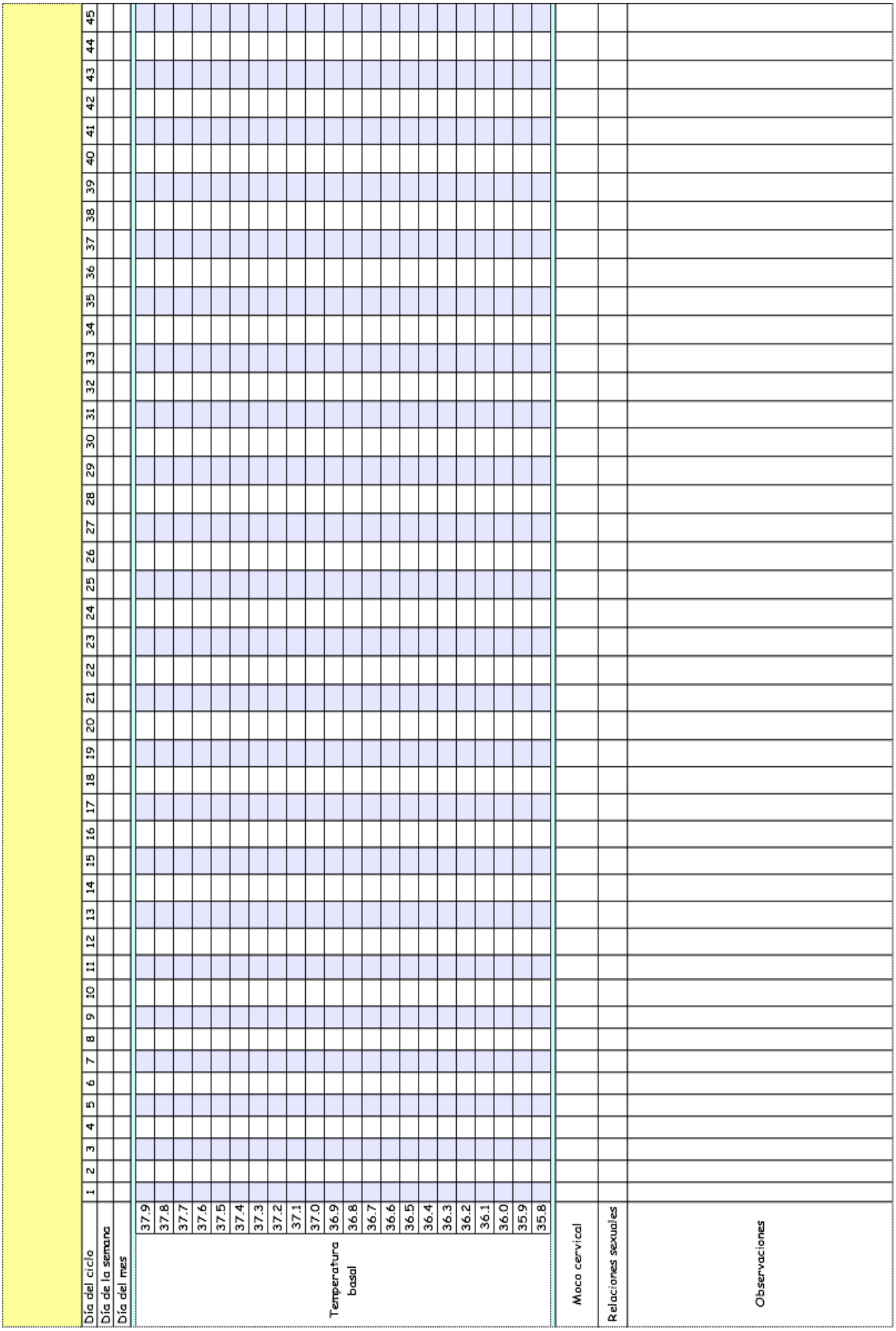
Para el registro de la temperatura, moco cervical, posición del cuello del útero y otros síntomas de fertilidad vas a necesitar una gráfica. Tienes varias opciones:

- **Descargarte una gráfica de Internet, imprimirla en papel e irla completando a mano**. Yo empecé así.

- **Crearte tu propia gráfica, por ejemplo, en Excel, y después imprimirla y completarla a mano**. Este fue mi siguiente paso. Lo bueno de crear tu propia gráfica es que puedes personalizarla según tus necesidades y modificar los casilleros cuando sea oportuno.

- **Utilizar alguna web que permita llevar todos estos registros de forma digital**. Esta fue mi última opción y la que a día más me gusta. Me parece muy cómodo llevar estos registros a través de Internet y, además, la mayoría de las webs ofrecen excelentes herramientas de interpretación de los datos, algo que se agradece cuando estás aprendiendo. Como es lógico suelen ser de pago, o al menos parte de sus servicios. Mis favoritas son 28días y Fertility Friend.

Si te decides por imprimir una gráfica, en la siguiente página puedes encontrar la que yo me diseñé para mi. Espero que pueda resultarte práctica, yo la usé muchísimo y hoy te la brindo junto con todos mis mejores deseos.


Día del ciclo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Día de la semana
Día del mes
Temperatura basal
37.9 37.8 37.7 37.6 37.5 37.4 37.3 37.2 37.1 37.0 36.9 36.8 36.7 36.6 36.5 36.4 36.3 36.2 36.1 36.0 35.9 35.8
Moco cervical
Relaciones sexuales
Observaciones